

ARBOVIROSES

Protocolo para o manejo clínico correto e oportuno

Cenário epidemiológico



DENGUE
DENV1/DENV2/DENV3

Transmissão autóctone
chikungunya

Oropouche
região extra-amazônica

Febre amarela

Zika

Aumento ESPERADO
de casos

```
graph TD; A[Aumento ESPERADO de casos] --> B[Aumento da demanda por atendimentos]; A --> C[Mais ações de vigilância em saúde]; B --> D[ATENÇÃO!!]; C --> E[Eventos Sentinelas principais perdas assistenciais]; D --> E; E --> F[Classificação inadequada]; E --> G[Manejo Inadequado];
```

Aumento da demanda
por atendimentos

Mais ações de
vigilância em saúde

ATENÇÃO!!

Eventos Sentinelas
principais perdas assistenciais

Classificação inadequada

Manejo Inadequado

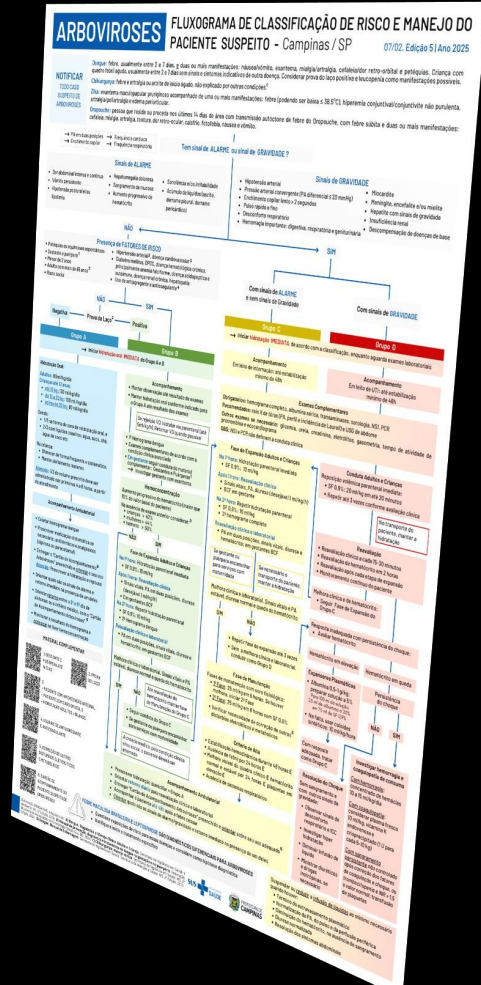
Dengue

Aspectos clínicos

SISTEMA	MANIFESTAÇÕES INCOMUNS OU ATÍPICAS
Neurológico	Convulsões febris em crianças pequenas Encefalopatia Encefalite/meningite asséptica Hemorragias intracranianas/trombose Derrames subdurais Mononeuropatias/polineuropatias/Síndrome de Guillain-Barré Mielite transversa
Gastrointestinal/ hepático	Hepatite/insuficiência hepática fulminante Colecistite acalculosa Pancreatite aguda Hiperplasia das placas de Peyer Parotidite aguda
Renal	Insuficiência renal aguda Síndrome hemolítico-urêmica
Cardíaco	Anormalidades de condução Miocardite Pericardite
Respiratório	Síndrome do desconforto respiratório agudo Hemorragia pulmonar.
Musculoesquelético	Miosite com aumento da creatina fosfoquinase (CPK) Rabdomiólise
Linfopoiético/medula óssea	Síndrome hemofagocítica associada à infecção SHFou linfocitose hemofagocítica púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) Ruptura esplênica espontânea (HLH), Infarto de linfonodo
Ocular	Hemorragia macular Acuidade visual reduzida Neurite óptica.
Outros	Síndrome da fadiga pós-infecciosa, depressão, alucinações, psicose, alopec

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO

Protocolo para o manejo clínico correto e oportuno



Arboviroses

DENGUE: FEBRE E duas ou mais manifestações:

Náusea, vômito exantema, mialgia, artralgia, cefaleia/dor retro orbital e petéquias. Criança com quadro febril agudo, usualmente entre 2 e 7 dias sem sinais e sintomas indicativos de outra doença.

CHIKUNGUNYA: FEBRE e artralgia (não precisa ser intensa), ou artrite de início agudo, não explicado por outras condições.

ZIKA: exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de uma ou mais manifestações: febre (podendo ser baixa $\leq 38,5^{\circ}\text{C}$), hiperemia conjuntival/ conjuntivite não purulenta, artralgia/poliartralgia e edema periarticular.

ORPOUCHE: área com transmissão autóctone de febre do Oropouche

TODO CASO SUSPEITO DE OUTRAS ARBOVIROSES DEVE SER CONSIDERADO SUSPEITO DE DENGUE E CONDUZIDO COMO DENGUE.

ATENDIMENTO

- **Exame físico completo:** PA em 2 posições, FC, FR, Avaliação de pulso, tempo de enchimento vascular, peso.
- Antecedentes pessoais: Comorbidades, medicamentos, vacinação, **risco social.**
- Antecedentes epidemiológicos: **Fatores de risco.**
- **Sinais de Alarme e Sinais de Gravidade.**

ATENDIMENTO

- NOTIFICAR
- HIDRATAR
- SOLICITAR HEMOGRAMA PARA **TODOS**
- MONITORAR

HEMOGRAMA DENGUE
GRUPOS A B

HEMOGRAMA COMPLETO
GRUPOS C D

CUIDADOS COM SUA SAÚDE - durante o tratamento

» Faça o tratamento completo

- Compareça nas consultas, retornos e exames solicitados e sempre leve este cartão para registros do seu atendimento.

» Evite esforço físico

- Descanse.
- O repouso é fundamental para a sua recuperação.

» Não tome anti-inflamatório e AAS sem orientação médica

- Siga as orientações que você recebeu do profissional de saúde para o tratamento.
- Alguns medicamentos podem causar sangramento em pacientes com dengue.

» Se sentir dores nas articulações, utilize compressa fria

- Coloque a compressa por 20 minutos e repita de 4 em 4 horas.

» Beba líquidos e soro na quantidade recomendada para o seu peso

- Se hidrate! É muito importante para evitar que a doença se agrave.
- Beba água, soro, chá, água de coco ou suco na quantidade indicada para o seu peso.

» Aumente os cuidados diários contra o mosquito

- A mesma pessoa pode adoecer mais de uma vez por diferentes sorotipos da dengue.

Dengue e outras arboviroses na gestante é mais grave!

Pode aumentar o risco de parto prematuro, sangramento e outras complicações para a mãe e o bebê, com maior risco de morte.

- Retorne diariamente no serviço de saúde para avaliação, até permanecer 2 dias seguidos sem febre.
- Use repelentes a base de DEET ou Icaridina.
- Proteja-se com roupas compridas e claras, para evitar picadas.
- O acompanhamento da gestante é diferente. Não o compare com o acompanhamento de outra pessoa.
- Siga todas as recomendações médicas.



Se sentir um dos “Sinais de Alarme”, procure um serviço com maternidade.

Referência

DEVISA
Departamento
de Vigilância
em Saúde

SUS SECRETARIA DE
SAÚDE

**PREFEITURA DE
CAMPINAS**



CARTÃO DE ACOMPANHAMENTO

ARBOVIROSES

DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA
E OROPOUCHE

CAMPINAS/SP

Edição 5 | Ano 2025

Nome: _____

Centro de Saúde da área de moradia: _____

Data de nascimento: ____/____/____ IDADE: _____

Data de início dos sintomas: ____/____/____ SINAN: _____

Gestante ou puérpera até 14 dias: () Sim () Não

Presença de outros fatores de risco: () Sim () Não

RETORNAR EM: ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____

ORIENTAÇÃO AO PACIENTE: Sinais de Alarme

RETORNE IMEDIATAMENTE AO CENTRO DE SAÚDE OU PRONTO SOCORRO SE VOCÊ APRESENTAR UM DESSES SINTOMAS:

- Tontura
- Dor na barriga muito forte
- Vômitos repetidos
- Suor frio
- Sangramentos espontâneos
- Sensação de desmaio
- Palidez
- Diminuição da urina
- Dificuldade de respirar
- Manchas roxas na pele
- Agitação ou sonolência



Os sinais de alarme surgem principalmente quando a febre desaparece, geralmente de 3 a 7 dias após o início dos sintomas, e podem indicar uma forma grave da doença.

SUS SECRETARIA DE
SAÚDE

Durante o seu tratamento, apresente este cartão sempre que retornar a um Serviço de Saúde.



GRUPO A

SEM

(SINAIS DE ALARME, GRAVIDADE,
FATORES DE RISCO, RISCO SOCIAL)
PROVA DO LAÇO NEGATIVA.

Grupo A

→ Iniciar **hidratação oral**

Hidratação Oral:

Adultos: 60ml/kg/dia

Crianças até 12 anos:

- até 10 kg: 130 ml/kg/dia
- de 10 a 20 kg: 100 ml /kg/dia
- acima de 20 kg: 80 ml/kg/dia

Sendo:

- 1/3 na forma de soro de reidratação oral, e
- 2/3 com líquidos caseiros: água, suco, chá, água de coco etc

Na criança:

- Oferecer de forma frequente e sistemática.
- Manter aleitamento materno

Atenção: 1/3 do volume prescrito deve ser administrado nas primeiras 4 a 6 horas, a partir do atendimento

Acompanhamento Ambulatorial

- Coletar hemograma dengue
- Prescrever medicação sintomática se necessário: antitérmicos e analgésicos (dipirona ou paracetamol)
- Entregar o "Cartão de Acompanhamento⁶ Arboviroses" preenchido e orientar o seu uso
- **Atenção:** Prescrever a hidratação e repouso
- Orientar quais são os sinais de alarme e retorno imediato na presença de um deles
- Orientar retorno entre o 3º e 5º dia de sintomas ou a critério médico, com o "Cartão de Acompanhamento Arboviroses"⁶
- Monitorar o resultado do hemograma e convocar se tiver hemoconcentração



GRUPO B

SEM

(SINAIS DE ALARME, GRAVIDADE,
~~FATORES DE RISCO, RISCO SOCIAL~~)
PROVA DO LAÇO NEGATIVA.

COM

(FATORES DE RISCO, RISCO SOCIAL)
OU
PROVA DO LAÇO POSITIVA.

Presença de FATORES DE RISCO

- Petéquias ou equimoses espontâneas
- Gestante e puerpera¹
- Menor de 2 anos
- Adulto com mais de 65 anos³
- Risco social
- Hipertensão arterial³, doença cardiovascular³
- Diabetes mellitus, DPOC, doença hematológica crônica, principalmente anemia falciforme, doença acidopéptica e autoimune, doença renal crônica, hepatopatia
- Uso de antiagregante e anticoagulante⁴

Manejo Clínico GRUPO B

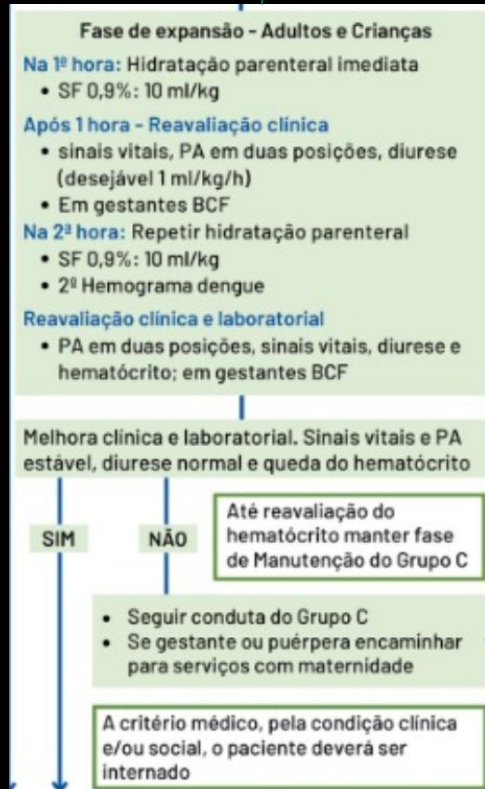
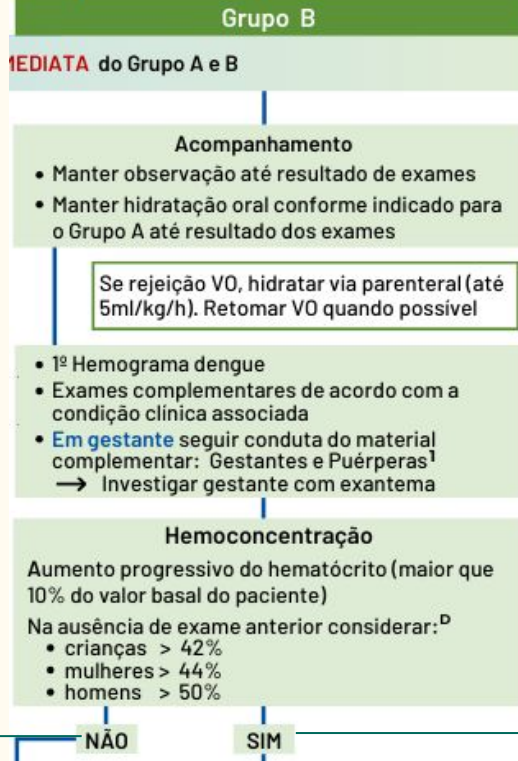
Acompanhamento Ambulatorial

- Iniciar hidratação oral imediatamente
- Prescrever hidratação domiciliar = Grupo A
- Orientar **retorno diário** para reavaliação clínica e laboratorial
- Entregar "Cartão de Acompanhamento Arboviroses" preenchido e orientar sobre seu uso adequado
- Acompanhar o paciente até 48h após a febre cessar
- Orientar quais são os sinais de alarme/gravidade e retorno imediato na presença de um deles

Se rejeição VO, hidratar via parenteral (até 5ml/kg/h). Retomar VO quando possível

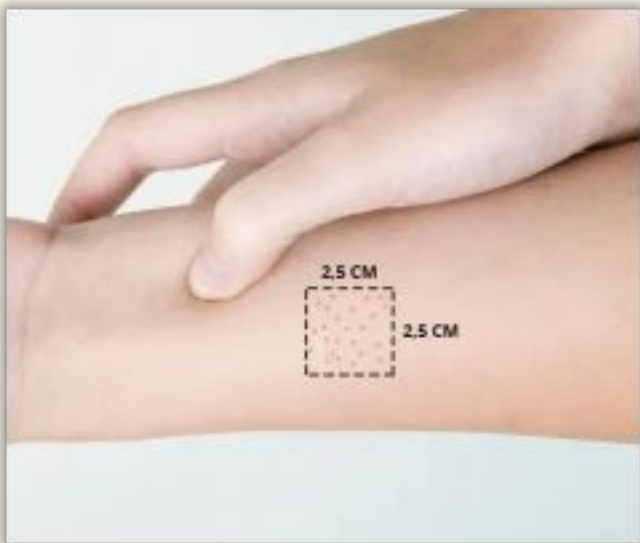


GRUPO B



Acompanhamento Ambulatorial

- Prescrever hidratação domiciliar = Grupo A
- Orientar **retorno diário** para reavaliação clínica e laboratorial
- Entregar "Cartão de Acompanhamento Arboviroses" preenchido e orientar sobre seu uso adequado⁶
- Acompanhar o paciente até 48h após a febre cessar
- Orientar quais são os sinais de alarme e retorno imediato na presença de um deles



POSITIVA (+)SE:

≥ 20 petéquias em **adultos**

≥ 10 petéquias em **crianças**

GRUPO C



Sinais de ALARME

- Dor abdominal intensa e contínua
- Vômito persistente
- Hipotensão postural e/ou lipotímia
- Hepatomegalia dolorosa
- Sangramento de mucosa
- Aumento progressivo de hematócrito
- Sonolência e/ou irritabilidade
- Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico)

- Iniciar hidratação EV imediatamente.
- Acionar remoção via SAMU.
- Gestante/puérpera: serviço especializado (maternidade)

Dor abdominal intensa e contínua, Vômito persistente, Hipotensão postural e/ou lipotímia, Hepatomegalia dolorosa, Sangramento de mucosa, Aumento progressivo de hematócrito, Sonolência e/ou irritabilidade, Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame pericárdico)

GRUPO D



Sinais de GRAVIDADE

- Hipotensão arterial
- Pressão arterial convergente (PA diferencial ≤ 20 mmHg)
- Enchimento capilar lento > 2 segundos
- Pulso rápido e fino
- Desconforto respiratório
- Hemorragia importante: digestiva, respiratória e geniturinária
- Miocardite
- Meningite, encefalite e/ou mielite
- Hepatite com sinais de gravidade
- Insuficiência renal
- Descompensação de doenças de base

Iniciar hidratação EV imediatamente e acionar remoção via SAMU

Hipotensão arterial, Pressão arterial convergente (PA diferencial ≤ 20 mmHg), Enchimento capilar lento > 2 segundos, Pulso rápido e fino, Desconforto respiratório, Hemorragia importante: digestiva, respiratória e geniturinária, Miocardite, Meningite, encefalite e/ou mielite, Hepatite com sinais de gravidade, Insuficiência renal, Descompensação de doenças de base

1º

É **caso suspeito** de dengue E (OU) outras arboviroses

2º

COM sinais de gravidade

GRUPO D

3º

SEM sinais de gravidade e **COM** sinais de alarme

GRUPO C

4º

SEM sinais de alarme e SEM sinais de gravidade e
COM fatores de risco

GRUPO B

5º

SEM sinais de alarme, SEM sinais de gravidade, NÃO pertence a grupo com Fatores de Risco E **prova do laço POSITIVA (+)**

GRUPO B

6º

SEM sinais de alarme, SEM sinais de gravidade, NÃO pertence a grupo com Fatores de Risco E **prova do laço NEGATIVA (-)**

GRUPO A

LABORATÓRIO

Teste Rápido NS1

Realizar até o 5º dia

RT-PCR

dengue, Chikungunya e Zika.

Realizar até o 5º dia

Dengue (grupos de risco)

IGM CHIKUNGUNYA

Após 6º dia de IS (IgM)

**Gestante suspeita
de infecção por Zika**

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS



FMB

- SEGUIR O FLUXOGRAMA DAS ARBOVIROSES
- Notificar FMB
- Hemograma completo
- Coletar sorologia na suspeita e 14 dias após
- Doxíciclina
-



Febre Amarela

Após avaliação CRITERIOSA

Deve:

- Seguir o “Fluxograma de Classificação de Risco e Manejo do Paciente Suspeito de Arboviroses”
- **SE** suspeita Febre Amarela, entrar em contato com a VISA Regional

Período de infecção □ **3 a 6 dias:**

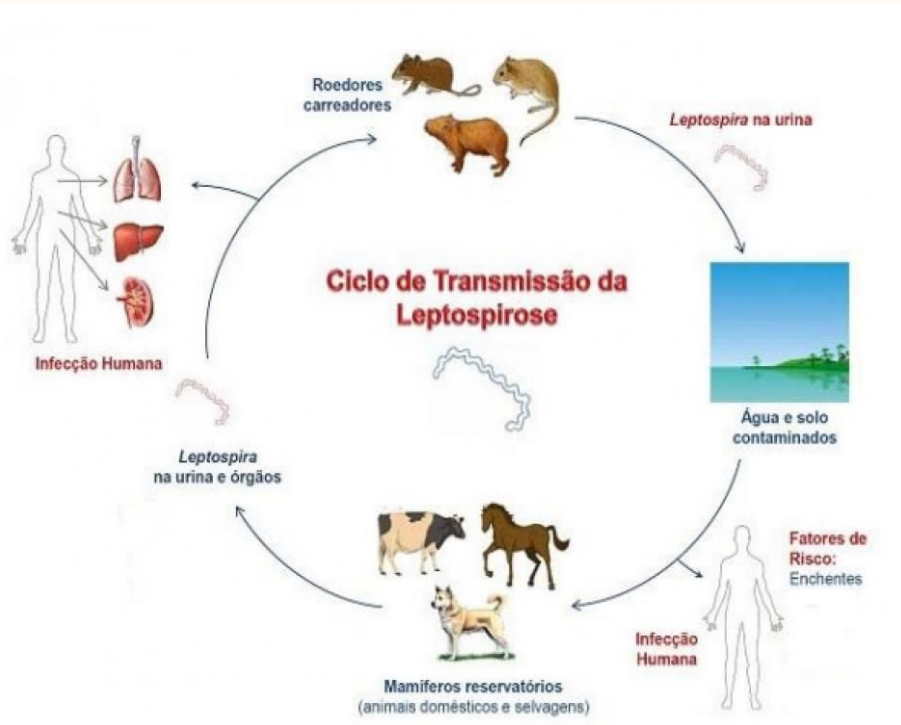
- Início súbito, febre, calafrios, cefaleia supraocular, lombalgia, mialgias, prostração, náuseas e vômito

Remissão: De **horas até 2 dias**

Período toxêmico □ **3 a 8 dias:**

- Insuficiência hepatorenal com icterícia.
- Manifestações hemorrágicas, sintomas neurológicos, coma e morte.

Leptospirose



Todo caso suspeito de dengue, após avaliação CRITERIOSA, com ANTECEDENTE ECOEPIDEMIOLÓGICO para leptospirose

Deve:

- Seguir o "Fluxograma de Classificação de Risco e Manejo do Paciente Suspeito de Arboviroses"
- Notificado imediatamente para leptospirose
- Coleta 1ª amostra para sorologia
- Solicitar hemograma COMPLETO
- Iniciar tratamento específico: **doxiciclina** ou **amoxicilina**

Vacina

Butantan

- de inclusão do imunizante no calendário nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Vírus vivo atenuado.
- Proteção contra os quatro sorotipos do vírus em dose única.
- Eficácia global de 74,4% na população de 12 a 59 anos.

Qdenga

- Vírus vivo atenuado.
- Duas doses (aprazamento de 90 dias).
- 10 a 14 anos de idade.
- Eficácia contra três sorotipos.